PEMODELAN LAPISAN PROSES BISNIS STUDI KASUS DENGAN NOTASI ARCHIMATE

MODUL 5

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:

Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

Studi kasus yang dipakai adalah profil Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang disusun pada Modul 1 (visi, misi, tujuan strategis, peta stakeholder, dan identifikasi masalah). Kutipan bukti pada tabel diambil dari profil tersebut, dengan sumber tabel atau bagiannya. Pemodelan memakai aplikasi Archi dan hanya mencakup lapisan bisnis.

A. Tabel Inventaris Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis

Tabel 1 berisi 7 aktor atau peran, 6 layanan bisnis, dan 7 proses bisnis. Nama elemen memakai istilah dari studi kasus. Hal yang tidak tertulis langsung di studi kasus dicatat sebagai asumsi pada bagian D.

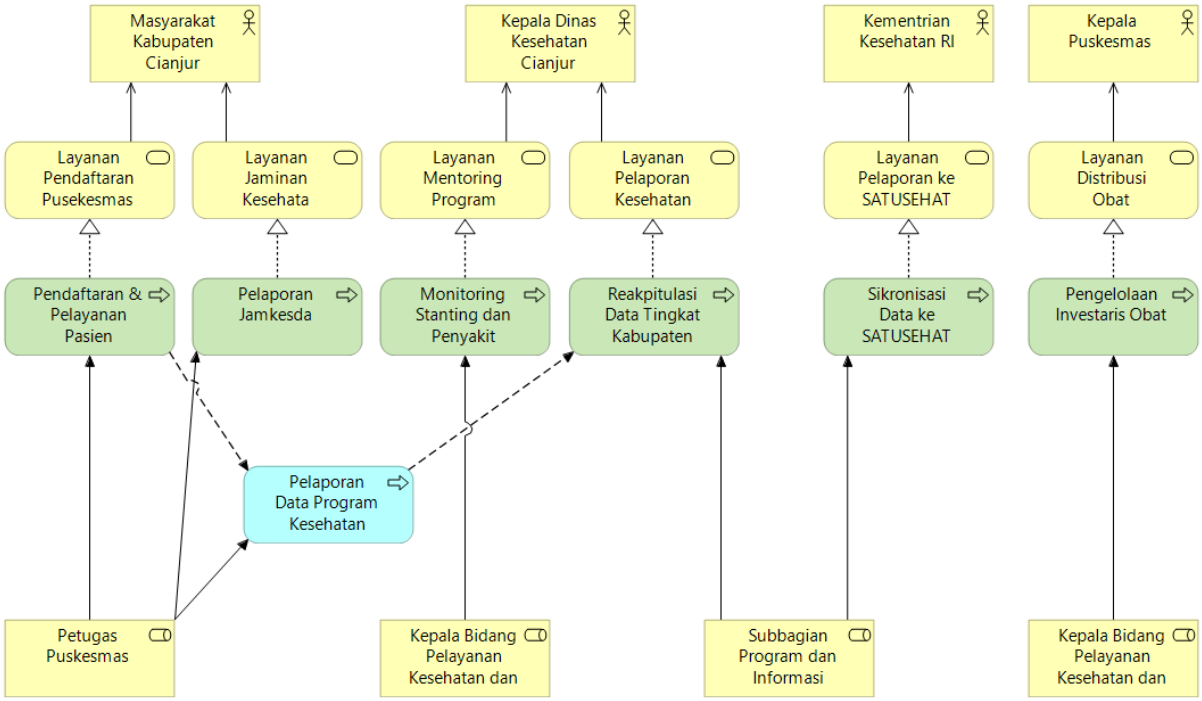
Tabel 1 Inventaris Aktor/Peran, Layanan Bisnis, dan Proses Bisnis

No	Elemen	Jenis	Kutipan bukti dari studi kasus
1	Masyarakat Kabupaten Cianjur	Business Actor	Stakeholder “Masyarakat Kabupaten Cianjur”: “Kemudahan akses layanan pendaftaran Puskesmas dan kepastian informasi kesehatan” (Tabel 1.1).
2	Kepala Dinas Kesehatan Cianjur	Business Actor	Stakeholder “Kepala Dinas Kesehatan Cianjur” berperan sebagai “Pengambil keputusan utama” dan menerima “Laporan ringkas berkala” (Tabel 1.1).
3	Kementerian Kesehatan RI	Business Actor	“Kepatuhan integrasi SATUSEHAT dan keamanan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten”; berperan sebagai “regulator” (Tabel 1.1).
4	Kepala Puskesmas	Business Role	Stakeholder “Kepala Puskesmas dan Petugas Lapangan” sebagai “Pengguna akhir (operasional)” (Tabel 1.1).
5	Petugas Puskesmas	Business Role	“Petugas Puskesmas mengalami beban kerja ganda karena harus mengisi data yang sama untuk pasien yang sama” (Tabel 1.2).
6	Subbagian Program dan Informasi	Business Role	“Kepala Subbagian Program dan Informasi / Tim Data TI”: “Pengelola teknis sistem dan infrastruktur” dengan kepentingan “sinkronisasi API ke Kemenkes” (Tabel 1.1).
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	Business Role	“Pengawas operasional kesehatan” dengan kepentingan “distribusi obat, dan layanan RME” (Tabel 1.1).
8	Layanan Pendaftaran Puskesmas	Business Service	“Kemudahan akses layanan pendaftaran Puskesmas” (Tabel 1.1); “Aplikasi pendaftaran Puskesmas” (Tabel 1.2).

9	Layanan Jaminan Kesehatan Daerah	Business Service	Tujuan strategis 3: “jaminan kesehatan daerah (Jamkesda/BPJS)”.
10	Layanan Monitoring Program Kesehatan	Business Service	Tujuan strategis 3: “otomatisasi sistem monitoring stunting, penyakit menular, dan jaminan kesehatan daerah”.
11	Layanan Pelaporan Kesehatan	Business Service	Tujuan strategis 1: “pelaporan data kesehatan masyarakat secara real-time dari seluruh Puskesmas”; Kepala Dinas menerima “Laporan ringkas berkala”.
12	Layanan Pelaporan ke SATUSEHAT	Business Service	Tujuan strategis 2: “integrasi aplikasi Layanan Kesehatan Publik dan Rekam Medis Elektronik (RME) Puskesmas ke platform SATUSEHAT Kemenkes RI”.
13	Layanan Distribusi Obat	Business Service	Kepentingan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK: “distribusi obat” (Tabel 1.1).
14	Pendaftaran dan Pelayanan Pasien	Business Process	Misi 1: “pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat Puskesmas dan Posyandu”; “Aplikasi pendaftaran Puskesmas” (Tabel 1.2).
15	Pelaporan Data Program Kesehatan	Business Process	“Pelaporan data program kesehatan (stunting, imunisasi, DBD) dari Puskesmas masih dilakukan secara manual dan terpisah per program” (Tabel 1.2).
16	Rekapitulasi Data Tingkat Kabupaten	Business Process	“Rekap data tingkat kabupaten lambat dan berisiko terlambat dalam pengambilan keputusan saat keadaan darurat kesehatan” (Tabel 1.2).
17	Sinkronisasi Data ke SATUSEHAT	Business Process	“Proses sinkronisasi dan integrasi data kesehatan daerah ke platform SATUSEHAT Kemenkes RI terhambat” (Tabel 1.2).
18	Monitoring Stunting dan Penyakit Menular	Business Process	Tujuan strategis 3: “otomatisasi sistem monitoring stunting, penyakit menular, dan jaminan kesehatan daerah”.
19	Pelaporan Jamkesda	Business Process	“Aplikasi pendaftaran Puskesmas, sistem inventaris obat, dan pelaporan Jamkesda belum terhubung dalam satu portal (belum ada SSO)” (Tabel 1.2).
20	Pengelolaan Inventaris Obat	Business Process	“sistem inventaris obat” (Tabel 1.2); “distribusi obat” (Tabel 1.1).

B. Diagram Lapisan Bisnis ArchiMate

Diagram hanya memuat elemen lapisan bisnis, yaitu Business Actor, Business Role, Business Service, dan Business Process. Relasi yang dipakai adalah assignment (peran ditugaskan pada proses), serving (layanan melayani aktor), realization (proses mewujudkan layanan), dan flow (aliran antar proses). Warna proses menunjukkan dukungan sistem informasi, dan dasarnya dijelaskan pada Tabel 2.



Gambar 1 Diagram Lapisan Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK ditampilkan dua kali pada diagram, tetapi merujuk ke satu elemen yang sama)

Tabel 2 Status Dukungan Sistem Informasi pada Proses Bisnis

Proses bisnis	Dukungan	Dasar dari studi kasus
Pendaftaran dan Pelayanan Pasien	Didukung sistem informasi	Ada “Aplikasi pendaftaran Puskesmas”, tetapi “belum terhubung dalam satu portal”.
Pelaporan Jamkesda	Didukung sistem informasi	Ada “pelaporan Jamkesda” pada aplikasi yang terpisah (belum ada SSO).
Pengelolaan Inventaris Obat	Didukung sistem informasi	Ada “sistem inventaris obat”, tetapi tidak terhubung dengan aplikasi lain.
Pelaporan Data Program Kesehatan	Didukung manual	“masih dilakukan secara manual dan terpisah per program”.
Rekapitulasi Data Tingkat Kabupaten	Didukung manual	Petugas “harus membuka banyak akun dan aplikasi terpisah untuk merekap data”; rekap “lambat”.
Sinkronisasi Data ke SATUSEHAT	Belum didukung	Format data belum sesuai standar nasional sehingga sinkronisasi “terhambat”.
Monitoring Stunting dan Penyakit Menular	Belum didukung	Otomatisasi monitoring masih menjadi tujuan strategis, belum ada sistemnya.

C. Analisis Kesenjangan dan Usulan Kebutuhan Sistem Informasi

Analisis dibuat dari perbandingan antara proses bisnis dan dukungan sistem informasinya pada Tabel 2. Dari tujuh proses, tiga sudah didukung aplikasi tetapi terpisah, dua masih manual, dan dua belum didukung. Tiga kesenjangan utamanya adalah sebagai berikut.

Kesenjangan	Proses bisnis terkait	Bukti dan dampak	Usulan kebutuhan sistem informasi
1. Pelaporan program dan rekap kabupaten masih manual dan terpisah per program	Pelaporan Data Program Kesehatan; Rekapitulasi Data Tingkat Kabupaten (didukung manual)	Laporan stunting, imunisasi, dan DBD dikirim terpisah per program sehingga "rekap data tingkat kabupaten lambat" dan keputusan darurat bisa terlambat.	Aplikasi Pelaporan Terpadu dengan form digital seragam untuk semua program, serta dashboard rekap kabupaten yang diperbarui otomatis. Ini menjawab tujuan strategis 1 (pelaporan real-time).
2. Aplikasi pendaftaran, Jamkesda, dan inventaris obat berjalan sendiri-sendiri	Pendaftaran dan Pelayanan Pasien; Pelaporan Jamkesda; Pengelolaan Inventaris Obat (didukung sistem informasi tetapi terpisah)	Aplikasi "belum terhubung dalam satu portal (belum ada SSO)" sehingga petugas mengalami "beban kerja ganda" dan harus membuka banyak akun.	Portal terpadu dengan SSO dan integrasi antar aplikasi lewat API, ditambah data induk pasien supaya data cukup diinput sekali.
3. Sinkronisasi ke SATUSEHAT terhambat dan monitoring penyakit belum otomatis	Sinkronisasi Data ke SATUSEHAT; Monitoring Stunting dan Penyakit Menular (belum didukung)	Format data "belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional" sehingga integrasi ke SATUSEHAT "terhambat"; otomatisasi monitoring baru berupa tujuan strategis 3.	Modul integrasi SATUSEHAT berbasis API dengan standar dan kamus data nasional, serta modul monitoring stunting dan penyakit menular yang otomatis.

Ketiga usulan saling berhubungan. Data induk dan standar data pada usulan 2 dan 3 dibutuhkan supaya aplikasi pelaporan terpadu pada usulan 1 dapat mengambil data tanpa input ulang, dan kebutuhan ini dapat ditelusuri langsung ke proses dan kutipan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

D. Asumsi

Hal berikut tidak tertulis langsung pada studi kasus dan dicatat sebagai asumsi:

- Petugas Puskesmas diasumsikan sebagai pelaksana Pelaporan Jamkesda karena studi kasus tidak menyebut pelaksananya.
- Subbagian Program dan Informasi diasumsikan sebagai pelaksana Rekapitulasi Data Tingkat Kabupaten dan Sinkronisasi Data ke SATUSEHAT, berdasarkan kepentingannya pada "sinkronisasi API ke Kemenkes".
- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK diasumsikan sebagai pelaksana Monitoring Stunting dan Penyakit Menular serta Pengelolaan Inventaris Obat.
- Urutan alur (Pendaftaran, Pelaporan Data Program, Rekapitulasi, Sinkronisasi) diasumsikan sebagai urutan logis dari proses yang disebut di studi kasus.
- Kepala Puskesmas diasumsikan sebagai pengguna Layanan Distribusi Obat.

- Nama layanan Monitoring Program Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, dan Distribusi Obat diturunkan dari tujuan strategis dan kepentingan stakeholder.

E. Lampiran

Berkas model ArchiMate: Tugas - P5 - Pemodelan Bisnis - Farhana Wahidiyah.archimate (view “Lapisan Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur”).